

25. 관절통증/부종

• 중요 포인트

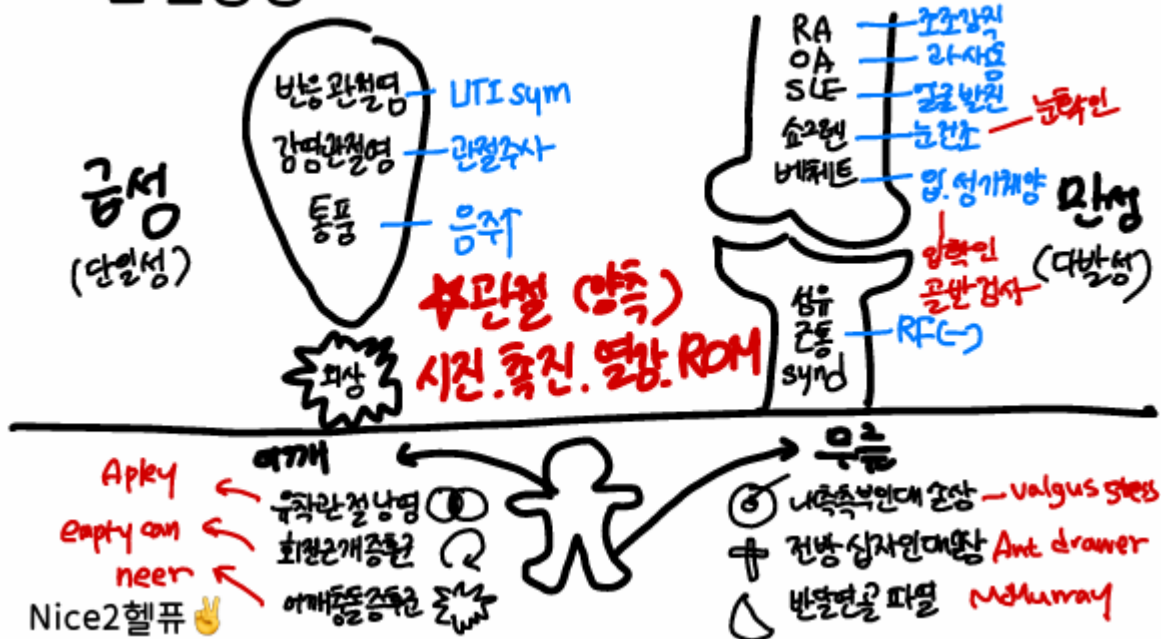
1. 관절손상과 장애를 시사하는 증상일 수 있어 조기 진단과 치료 중요
2. 단일/다발성 관절통증/부기에 따라 원인 구별하고 치료하기

• Overview

1. 초기 감별: 급성/만성, 단일/다발로 줄기 잡기 -> 급성 단일(통풍, 감염) vs 만성 다발(RA, OA)
2. 과음(통풍), 주사(감염), 조조강직 시간(RA/OA) 등의 특징적 증상 확인
3. 신체진찰: 양측 비교와 동선 최소화: 시진→촉진→ROM→특이검사
4. X-ray 와 염증/항체 피검사 + 통풍) 관절액 천자, 쇼그렌) 눈물 분비 검사 등 질환별 특수 검사
5. 치료 및 주의점: 약물 선택과 스테로이드 경고
6. 생활 교육: 질환 맞춤형 가이드라인 제시

28. 관절통증

🎨 그림으로 시작하는 CPX



● 평가 목표

원인			
관절	염증성 - 단일관절: 감염관절염 - 다발관절: 류마티스관절염 비염증성: 골관절염, 외상		
관절 외	전신성: 섬유성근육통 국소성: 근막통증질환		
평가목표			
1) 병력청취와 신체진찰로 관절통/관절부기의 원인 감별 2) 필요한 환자교육 시행 3) 적절한 진단 및 치료 계획 수립			
구체적인 성과			
병력 청취	통증/부기의 주요 특성	Onset: 급성<6 주<만성, 갑자기/서서히, 상황 - 아침/저녁, 활동 시 Location: 위치, 양측성, 통증의 이동, 방사통 Duration: 지속시간/조조강직 (골관절염<1 시간<류마티스) Character: 압통/발적/종창/열감/비빔소리/운동 제한	
	동반 증상과 위험 요인	Associated Sx [전신] 발열/오한/체중 감소/피로 [류마티스] 호흡곤란 [쇼그렌] 눈/입 마름 [베체트] 구강궤양/성기궤양/안구 충혈+통증 [루푸스] 피부발진/햇빛 알러지/레이노(루푸스, 쇼그렌) [반응 관절염] 배뇨통/설사/감기 기운 [섬유근통] 수면장애/불안/우울/인지기능 저하 [골관절염] 키/몸무게	
		Factor: 사용빈도/휴식/자세/과음/해당 관절 주사	
신체 진찰	관절의 상태를 확인하는 신체진찰	[관절 시진] 발적, 부종, 결절, 변형 [관절 촉진] 압통, 열감, 불안정성, 잠김현상 [관절 청진] 비빔소리 [운동검사] 능동->수동->저항 반드시 양측 비교	
	원인을 감별하기 위한 신체진찰	[눈] 포도막염 [입] 구강 궤양 - 베체트병, 구강 건조 - 쇼그렌 [흉부] 호흡음 청진 - 류마티스관절염 [피부] 발진 [생식기] 시진 - 베체트병 [무릎] Valgus/Varus stress test, McMurray test, Drawer test [어깨] Neer test, Hawkins-kennedy test, Empty can test [허리] Schober test, SLR test, Patrick test	
진단 및 치료	류마티스 관절염	혈청 RF, 항 CCP 항체, CBC, ESR, CRP 관절 X 선 사진, 다른 기관 침범(눈, 심장, 폐)	DMARDs(MTX 등), NSAIDs 생물학적 제제, 스테로이드
	골관절염	관절 X 선 사진	NSAIDs, 체중 감량, 휴식
	통풍 관절염	관절 천자, 혈청 요산	NSAID, 콜히친, 스테로이드 Allopurinol (2 차 예방 목적)
	쇼그렌 증후군	Schimer's test, anti-Ro/La, 침샘 스캔	NSAID, Hydroxychloroquine, 인공눈물, 수분 보충
	베체트병	CBC, ESR, CPR, skin pathergy test	콜히친, 스테로이드, 생물학적 제제
	루푸스 관절염	항핵항체, 항 dsDNA 항체, CBC, 소변검사 보체검사	Hydroxychloroquine, NSAID, Cyclophosphamide, 스테로이드
	섬유근통증후군	배제 진단	충분한 수면 및 식사, 운동치료, 항우울제
	강직척추염	HLA-B27, 골반 방사선 촬영	재활 및 운동 치료, NSAID, 생물학적 제제
	감염 관절염	관절 천자, 관절액 배양, 단순 방사선 촬영	항생제

	반응 관절염	관절 천자, 단순 방사선 촬영, HLA-B27	NSAIDs, 스테로이드, Azathioprine Methotrexate
	회전근개 증후군	관절 X 선 사진/MRI, 관절 초음파	NSAIDs, 스트레칭 및 운동, 수술
	내측 측부인대 손상	관절 X 선 사진/MRI	휴식, NSAIDs, 부목 고정, 수술
환자교육	약물치료	통증이 심하시면 진통제로 먼저 조절해보자 오남용 및 부작용의 위험이 있으니 반드시 용법에 맞춰 복용할 것 스테로이드 주사는 감염을 유발할 수 있으니 자주 맞지말 것	
	생활습관 교육		

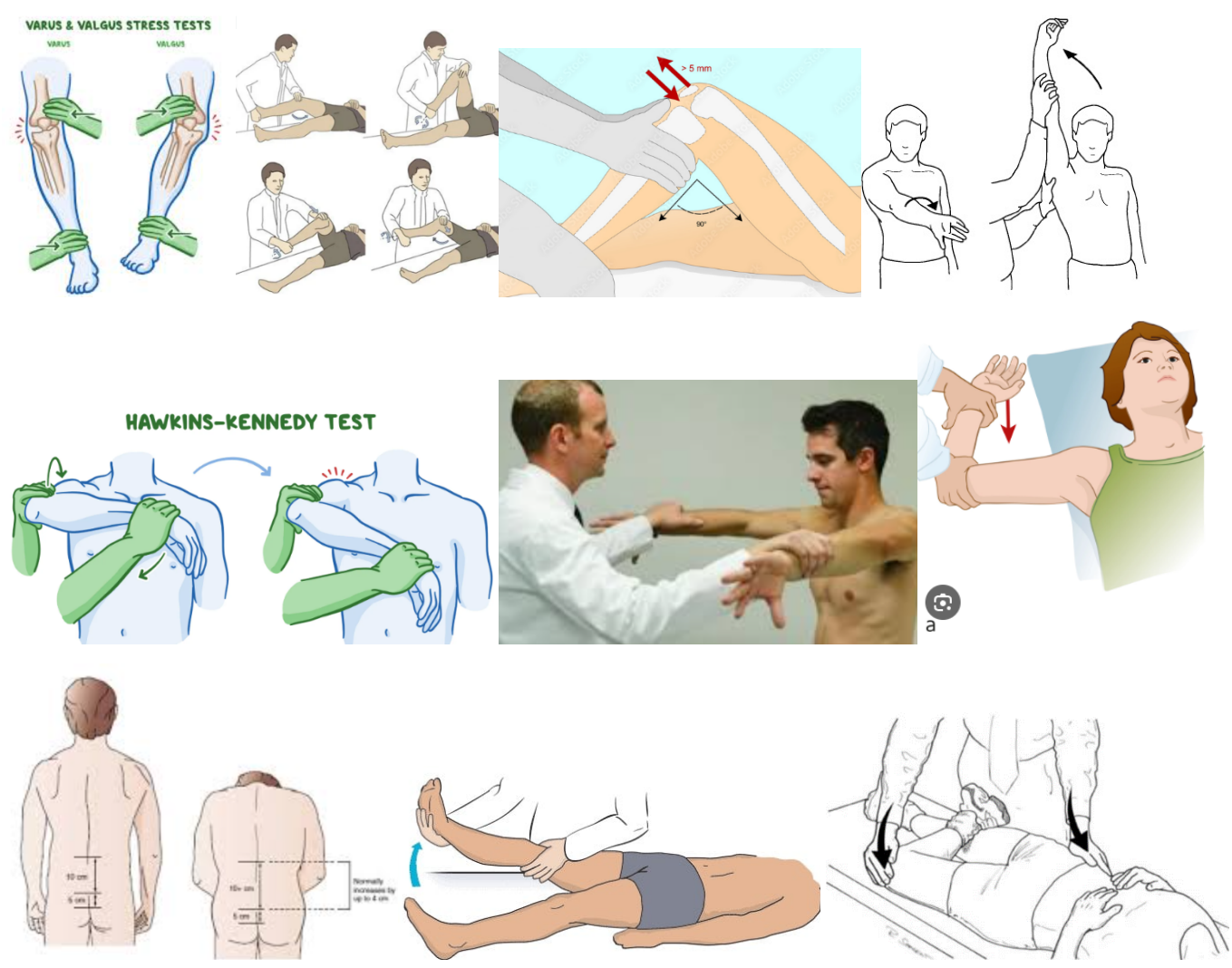
• 원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
급성 < 6 주						
감염	통풍 0+1	몸에 요산이 쌓여서 관절을 찌르고 염증 발생	반복적인 급성 통증 단일 관절염 (엄지발가락) 과음, 과식의 사회력	관절 압통, 발적, 부종	관절 천자, 혈청 요산	NSAID, 콜히친, 스테로이드, Allopurinol (2 차 예방 목적)
	가성통풍	관절에 칼슘 성분 결정 쌓임	주로 무릎이나 손목, 고령,	관절 압통, 발적, 부종	관절천자, 관절 Xray	NSAID, 콜히친, 스테로이드
	감염 관절염 1	관절 안에 세균으로 심한 통증과 붓기	단일 관절염, 발열, 오한 동반 관절 주사, 관절 외상의 과거력	관절 압통, 발적, 부종	관절 천자, 관절액 배양, 단순 방사선 촬영	항생제
	반응 관절염	장/비뇨 감염 이후 면역 반응이 지나쳐 관절까지 통증	장염/비뇨기 감염(성병)의 병력 휴식 시 통증, 발열, 피로 동반	관절 압통, 부종, 뻣뻣함, 급성 비대칭적 관절	관절 천자, 단순 방사선 촬영, HLA-B27	NSAIDs, 스테로이드, Azathioprine, Methotrexate
	외상 관절염	다친 관절이 시간이 지나 닳음	관절 외상력	관절 압통, 발적, 부종, 운동 제한	단순 방사선 촬영	NSAID, 재활 및 운동 치료
만성 > 6 주						
자가 면역	류마티스 관절염	면역체계가 잘못 작동해 자기 관절을 공격	MCP/PIP 관절의 다발성 침범, 대칭성, 피로감, 식욕부진 1 시간 이상 조조강직 관절 외(눈, 심장, 폐, 신장)	관절의 압통, 종창, 류마티스 결절, 특징적 손가락 변형	혈청 RF, 항 CCP 항체, CBC, ESR, CRP, 관절 X 선 사진	DMARDs(MTX 등), NSAIDs, 생물학적 제제, 스테로이드
	루푸스 관절염 1+1	면역체계 이상으로 정상 조직을 공격	젊은 여성, 피부 발진, 구강궤양, 광과민성, 레이노 현상 반복적 유산력 (항인지질항체증후군)	구강 궤양, 피부 시진, 관절 압통 탈모	항핵항체, 항 dsDNA 항체, CBC, 소변검사, 보체검사	Hydroxychloroquine, NSAID, Cyclophosphamide, 스테로이드
	쇼그렌 증후군 1	면역체계가 주로 침샘/눈물샘 공격 + 관절도	눈, 입 안 건조증, 마른기침	눈 마름 확인, 침샘 비대, 레이노 현상	Schimer's test, anti-Ro/La, 침샘 스캔	NSAID, Hydroxychloroquine, 인공눈물, 수분 보충
면역	강직척추염	척추와 골반 관절에 염증, 점점 굳고 움직임이 제한	젊은 남성, 허리 통증, 아침에 아프고 운동하면 나아짐 포도막염, 갈비연골염	쇼버 검사, 흉곽 확장 감소, 패트릭 테스트 시 반대측 천장관절 통증	HLA-B27, 골반 방사선 촬영	재활 및 운동 치료, NSAID, 생물학적 제제
	베체트병 1	혈관에 염증이 생김(입/피부/눈/관절 영향)	구강/성기 궤양, 포도막염, 피부병변	구강/ 성기궤양, 결절홍반, 안구 충혈	CBC, ESR, CPR, skin pathergy test	콜히친, 스테로이드, 생물학적 제제
비염증	골관절염 2+1	고령/과사용 관절의 연골이	관절을 오래 쓴 고령 환자 DIP 관절, 무릎의 다발성		관절 X 선 사진	NSAIDs, 체중 감량, 휴식

		낮는 퇴행성 질환	침범, 활동시 통증 심해짐 30 분 이내로 지속되는 조조강직			
	섬유근통증 증후군	특별한 원인 없이 온몸 근육과 관절이 아픔	Axial 주위 통증, 압통, 전신 피로, 수면장애, 인지 기능 저하, 불안, 우울	-	배제 진단	충분한 수면 및 식사, 운동치료, 항우울제
관절 외						
관절낭	유착관절낭 염(오십견)	어깨 관절을 싸는 막이 굳고 뻣뻣해짐	어깨 통증, 밤에 더 심한 통증	어깨 관절의 능동/수동 운동 제한	관절 X 선 사진/MRI, 관절 초음파	충분한 스트레칭 및 운동, 수술, 스테로이드 주사
힘줄	회전근개 증후군 1+1	어깨 힘줄이 뼈에 반복적으로 부딪히고 염증	어깨 통증 , 어깨관절 운동 제한	어깨 관절의 능동 운동 제한 (수동 운동 정상)	관절 X 선 사진/MRI, 관절 초음파	NSAIDs, 스트레칭 및 운동, 수술
	팔꿈치 건병증 (상과염)	골프/테니스 엘보로 팔꿈치 힘줄 손상	팔꿈치 안쪽/가쪽의 통증 오랜 시간 팔을 쓰는 운동을 한 환자	팔꿈치 밀 압통점, 손목 운동 시 통증	관절 X 선 사진/MRI, 관절 초음파	휴식, 스트레칭, NSAIDs, 수술
연골	무릎연골연 화증	무릎 앞 연골이 약해져 마찰/손상으로 통증	무릎 앞쪽이 빠근, 계단 오르내릴 때 통증	운동시 비빔소리, 슬개골 압박검사 양성	관절 X 선 사진/MRI	NSAID, 근력 강화 운동
	반달연골 파열	무릎 관절 사이의 반달 모양 연골이 찢어짐	무릎 통증, 대퇴사두근 위축, 외상력	무릎 운동 제한, Mcmurray test	단순 방사선검사, MRI, 관절경검사	NSAID, 부목고정, 수술
인대	내측 측부인대 손상 1	무릎 안쪽 인대가 늘어나거나 찢어짐	운동 중 무릎에 가해진 외반력 (축구, 스키 등)	무릎 내측 종창, 압통, Valgus stress test (+)	관절 X 선 사진/MRI	휴식, NSAIDs, 부목 고정, 수술
	십자인대 손상	무릎 중심의 십자 모양 인대가 끊어짐	착지/방향 전환 중 '뚝'하는 소리와 함께 발생한 극심한 통증	Anterior drawer test 양성	관절 X 선 사진/MRI	휴식, NSAIDs, 인대재건술
윤활막	윤활막염	부드러운 관절 움직임 위해 윤활액 만드는 막에 염증이 생김	운동할수록 통증	관절 종창, 힘줄 부위 누를 때 압통	ESR/CRP, MRI, 조직생검	휴식, 얼음 찜질, 부목 고정

O	[언제] 언제부터 아팠나요? [갑자기/서서히] 갑자기 아프셨나요? 서서히 아프셨나요? [상황] 어떤 상황에 통증이 있나요? 가만히/움직일 때, 아침/활동 중 (아침 통증 시) 아침에 뻣뻣한 게 얼마나 오래 가나요? > r/o OA/RA	
L	[위치] 어디가 아픈가요? 양쪽 다 아픈가요? 아픈 관절을 전부 짚어보시겠어요? [이동] 아픈 부위가 변하나요? [방사통] 어디가 가장 아픈지 체크 - P/Ex	
D	[지속] 통증은 얼마나 지속	
Co	점점 더 심해지나요?	
Ex	이전에도 이런 적 있으셨나요? □ 치료는? 진통제?	
C	어떤 식으로 아프신가요? (개방형) □ 육신/깊은 부위/관절 주변 (폐쇄형) [압통] 눌렀을 때 아픈가요? [발적] 붉어진 곳 있나요? [종창] 부어있나요? [열감] 만졌을 때 따뜻한가요? [비빔소리] 움직일 때 소리 [움직임 제한] 움직임에 제한이 있나요? [NRS]	
A	[전신] 발열/오한/체중 감소/피로 [류마티스] 호흡곤란 [쇼그렌] 눈/입 마름 [베체트] 구강궤양/성기궤양/안구 충혈+통증 [루푸스] 피부발진/햇빛 알러지/레이노(루푸스, 쇼그렌) [반응 관절염] 배뇨통/설사/감기 기운 [섬유근통] 수면장애/불안/우울/인지기능 저하 [골관절염] 키/몸무게	[전신] 발열/오한/피로/체중감소, 키/몸무게 [호흡기] 호흡곤란/감기기운 [소화기] 설사 [비뇨기] 배뇨통 [피부] 피부발진/햇빛 알러지/레이노 [정신] 우울/불안 [눈,입] 안구 충혈/통증/건조, 구강 건조/궤양
F	휴식/활동 중? 그 관절을 많이 사용하시나요? r/o 골관절염 전날 과음했나요? r/o 통풍 관절 스테로이드 주사/침? r/o 감염 관절염	
E	마지막 건강검진? 골다공증?	
외	관절 다친 적/수술력	
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? HTN/DM/TB/간염	
약	복용중인 약물?	
사	기본: 음주/흡연/직업 + 운동 --> 관절에 무리가 갈만한 작업/운동을 하시나요?	
가	관절염 / 류마티스 질환	
여	[월경] 규칙/주기/양/통 [산과력] 유산 루푸스, 임신계획	
PEx	기본	V/S 확인 (혈압, 맥박, 호흡수, 체온) 1 눈 : 빈혈/포도막염 베체트, 강직척추염, 쇼그렌 2 입 : 탈수/궤양 베체트, 루푸스, 쇼그렌 3 피부 : 발진 류마티스 관절염, 루푸스, 베체트 / 성기 궤양 >> 외음부진찰로 옮기기? r/o 베체트
	관절 (양측 비교) r/o 관절 or 관절 외	[시진] “양쪽 무릎 걷어주세요” -> 발적/부종/결절/변형 [촉진] 압통/열감/불안정/잠김 불안정 : 손으로 당기거나 밀어 : 혈검고 흔들림 잠김 : 움직이는 중에 딱 멈춤/뚝소리 : 걸려서 안움직임 [청진] “무릎 움직일 때 소리나나요? -> 한번 들어볼까요? 움직여보세요” 비빔소리 (청진기 대고 수동 운동) [운동] (양측) 능동: 혼자서 움직여보기/수동 : 내가 움직여보기/저항: 미는 방향 반대로 힘주기 능동이 괜찮으면 수동 스킵해도 괜찮다 - 무릎: 침대 걸터앉아 Ext -> 옆드려서 Flex -> 똑바로 누워서 특이 검사

		- 어깨: 앞으로 나란히, 만세, 팔벌려 자세하며 어깨 돌리기
특이		[무릎] 건측부터 Valgus/Varus stress test-측부인대 손상 “다리 들어서 무릎 내측/외측 밀기 -> 아프신가요?” McMurray test-측부인대 손상 “한 손으로 무릎 안쪽으로 밀고, 발목 잡고 돌려” 가운데/왼쪽/오른쪽 Drawer test- 십자인대 손상 “이어서 무릎 안쪽/바깥쪽으로 밀어보겠습니다” [어깨] 건측부터 ROM test “(능동) 앞으로 나란히, 만세, 팔벌려 해서 어깨 앞뒤로 돌려보세요” -> 수동 & 저항 Empty can test-회전근개증후군 thumbs down (-> 100 도 벌려서 눌러봐: empty can Neer test-어깨 염증 “어깨 나란히 -> thumbs up -> thumbs down -> (능동) 양측 팔 올려보세요 -> (수동) 제가 올려볼게요” Hawkins-kennedy test-건봉하 충돌 증후군 “뺨날개 -> 한 손으로 손목 내리고, 다른 손으로 팔꿈치 올리기” Addension test - 회전근개 [허리] Schober test-강직 척추염 “허리 숙여보세요 -> 하의 탈의했다고 가정하겠습니다 -> 앞으로 숙여보세요” (침대로 누워주세요) SLR test-디스크, “무릎 펴고, 발목 잡고, 다리 천천히 올려 -> 아픈가요?” Patrick test “다리를 반대쪽 무릎에 올리고 누르기” hip joint inflammation “오른쪽 4 자 다리 -> 한 손 오른쪽 다리에, 다른 손 왼쪽 무릎 -> 아픈가요? (오른쪽 고관절 아프거나/ 왼쪽 무릎 아프거나) ”
흉부(종철때까지)		호흡음 청진 류마티스, 루푸스, 강직척추염



진단		
검사	기본	관절부위 X-ray + 흉부엑스레이 혈중 항체 검사 혈중 염증 수치
	특이	[통풍, 가성통풍] 관절액 천자 [관절 외] MRI [쇼그렌] 침샘 검사, 시머 테스트-눈물이 잘 나오는 지 검사
치료	통증 조절 : 소염진통제 감염 : 항생제 쇼그렌 : 인공눈물/수분 보충 섬유근육통증 증후군 : 항우울제 류마티스 질환 : 스테로이드, 면역 조절 관절 외 질환 : 재활, 스트레칭, 휴식, 수술	
교육	통증조절) 통증이 심하시면 진통제로 먼저 조절해보자 오남용 및 부작용의 위험이 있으니 반드시 용법에 맞춰 복용할 것 스테로이드 주사는 감염을 유발할 수 있으니 자주 맞지말 것 진통제 먹어봤는데 효과 없다고 할때) 용법/용량 준수 여부: "혹시 아플 때만 불규칙하게 드시진 않았나요? 관절염 약은 혈중 농도가 일정하게 유지되어야 염증 조절 효과가 제대로 나타납니다." 약물 작용 시간: "이 약은 효과가 나타나기까지 보통 1~2 주 정도 꾸준히 복용해야 염증이 가라앉기 시작합니다." 생활 습관과의 연관성: "약을 드시면서도 관절에 무리가 가는 행동(무거운 짐 들기, 무리한 운동 등)을 반복하면 약효가 가려질 수 있습니다." 생활습관 교육) [골관절염] 체중 부하를 줄이기 위해 체중감량할 것 [류마] 금연- 담배가 류마위험인자 [루푸스] 임신계획시 꼭 치료 루푸스로 유산 가능 [쇼그렌] 인공눈물+충치예방 구강관리 과도한 사용으로 증상이 유발되고 있을 경우, 관절이 회복할 동안 휴식을 취할 것 관절에 무리가 가지 않는 선에서 의사가 허용하는 스트레칭 및 운동(수영)을 꾸준히 할 것 음주 및 흡연은 통증을 악화할 수 있으므로 금주, 금연할 것	

[어깨]

① 준비 및 시진 (30 초)

의사: "어깨를 좀 확인해 보겠습니다. 환부 노출을 위해 환자복을 조금 내려도 될까요? (동의 후) 양쪽 어깨 높이가 대칭인지, 붉게 부어오르거나 근육이 마른 곳은 없는지 확인하겠습니다."

포인트: 양측 어깨를 동시에 보며 발적, 부종, 결절, 변형을 확인합니다.

② 촉진 (30 초)

의사: "제가 어깨 주변을 눌러볼 건데, 아프시면 말씀하세요." (견측부터 시작)

동선: 빗장뼈(쇄골) -> 어깨 봉우리 -> 어깨 관절 앞뒤를 꼭꼭 누릅니다.

의사: "열감이 있는지 확인하겠습니다." (손등으로 양쪽 어깨 체온 비교)

③ 관절 가동 범위 (ROM) 확인 (1 분) - 가장 중요

의사: "이제 제 동작을 따라 해 보세요. 아프면 바로 멈추세요."

굴곡/외전: "앞으로 나란히 해서 만세~ 옆으로 벌려서 만세~"

내회전/외회전: "옆중쉬어 자세에서 손을 등 위로 올려보시고, 다음엔 머리 뒤로 깎지 껴보세요."

- 판단 로직:
 - 환자가 스스로 못 움직이면(능동 제한), 의사가 직접 팔을 들어 올려봅니다(수동 확인).
 - 수동으로도 안 올라가면? 유착관절낭염으로 판단하고 다음 단계 생략 가능.
 - 수동으로는 올라가면? 회전근개 문제이므로 아래 특이 검사 시행.

④ 특이 검사 (1 분) - 회전근개 및 충돌 증후군 의심 시

- Empty Can Test (근력 저하 확인):
 - 의사: "양팔을 비스듬히 벌리고 엄지손가락이 바닥을 향하게 돌려보세요. 제가 아래로 누를 테니 버텨주세요."
 - 결과: 힘없이 툭 떨어지면 회전근개 파열 의심.
- Neer Test (충돌 증후군 확인):
 - 의사: "어깨에 힘을 빼시고요. 제가 팔을 귀 옆까지 높이 들어 올려보겠습니다." (한 손으로 견갑골 고정 후 수동 거상)
- Hawkins-Kennedy Test (충돌 증후군 확인):
 - 의사: "팔을 앞으로 들어서 팔꿈치를 90 도로 굽혀보세요. 제가 손목을 아래로 내려보겠습니다." (닭날개 자세에서 내회전)

[무릎]

① 준비 및 시진 (30 초)

의사: "무릎 상태를 확인하기 위해 바지를 무릎 위까지 걷어주실 수 있을까요? (동의 후) 양쪽 무릎을 비교하며 붉게 부어오른 곳(발적/부종)이나 변형된 곳이 있는지 확인하겠습니다."

포인트: 반드시 양측을 동시에 노출시켜 비교합니다.

② 촉진 및 청진 (1 분)

의사: "제가 무릎 주변을 눌러보겠습니다. 아픈 곳이 있으면 말씀해 주세요."

동선: 무릎뼈(슬개골) 주변 -> 안쪽/바깥쪽 관절선(Joint line)을 꼭꼭 누릅니다.

의사: "손등으로 양쪽의 온도를 비교해 보고(열감 확인), 혹시 흔들거림이 있는지 보겠습니다."

청진: "무릎을 굽혔다 펴 때 소리가 나는지 들어보겠습니다." (청진기를 무릎에 대고 환자에게 다리를 움직이게 함)

③ 관절 가동 범위 (ROM) 확인 (30 초)

의사: "다리를 끝까지 쭉 펴보시고, 이제 가슴 쪽으로 최대한 굽혀보세요." (능동 ROM)

의사: "제 손에 힘을 빼시면 제가 직접 움직여보겠습니다." (수동 ROM)

판단: 끝범위에서 통증이 있는지, 운동 제한이 있는지 확인합니다.

④ 특이 검사 (1 분 30 초) - 가장 효율적인 콤보 순서

눅힌 상태에서 다리 각도를 조금씩 조절하며 이어갑니다.

1. Valgus / Varus Stress (측부인대):
 - 의사: "무릎에 힘을 빼시고요, 제가 다리를 살짝 들어서 옆으로 밀어보겠습니다. 아프신가요?"
 - 자세: 무릎을 20~30 도만 살짝 굽힌 상태에서 안쪽과 바깥쪽으로 힘을 줍니다.

2. Drawer Test (십자인대):

- 의사: "이제 무릎을 90 도로 세우겠습니다. 제가 발을 고정하고 정강이뼈를 당기고 밀어보겠습니다."
- 자세: 환자 발등에 살짝 앉아 고정된 뒤, 두 손으로 정강이 상단을 잡고 앞뒤로 흔듭니다.

3. McMurray Test (반달연골):

- 의사: "무릎을 완전히 굽힌 뒤에 발목을 돌리면서 펴보겠습니다. 걸리는 느낌이나 통증이 있는지 보세요."
- 자세: 발꿈치를 잡고 안쪽/바깥쪽으로 회전시키며 무릎을 천천히 펴니다.

[손가락]

① 시진 (30 초)

의사: "양손을 손등이 보이게 책상 위에 올려보시겠어요? 다음엔 손바닥이 보이게 뒤집어보세요."

포인트:

- 부종 및 발적: 마디가 부어있는지(Sausage digit 등) 확인합니다.
- 결절: 끝 마디(DIP)에 툇 튀어나온 결절이 있는지 봅니다 (OA 의심).
- 변형: 손가락이 바깥쪽으로 휘었는지, 특징적인 변형이 있는지 확인합니다.
- 피부 및 손톱: 루푸스 의심 시 손등의 발진을, 건선 관절염 의심 시 손톱 변형을 확인합니다.

② 촉진 (1 분)

의사: "제가 마디마디를 눌러보겠습니다. 아프시면 말씀하세요."

● 포인트:

- 압통 확인: 양손의 MCP, PIP, DIP 마디를 하나씩 꺾꾹 눌러 통증 부위를 찾습니다.
- 열감 확인: 손등으로 관절 부위의 온도를 체크합니다.
- Squeeze Test: MCP 마디 전체를 양옆에서 한꺼번에 꺾 쥐어봅니다. 이때 통증이 심하면 RA 가능성이 높습니다.
-

③ 운동 범위(ROM) 및 기능 확인 (30 초)

의사: "주먹을 꽉 쥐어보시고, 이제 손가락을 최대한 꺾 펴보세요."

의사: "제 손가락을 한번 꺾 잡아보시겠어요?" (악력 확인)

- 포인트: 통증으로 인해 주먹을 쥐기 힘들거나 펴는 동작에 제한이 있는지 확인합니다.

④ 전신 질환 감별을 위한 추가 진찰 (30 초)

손가락 통증은 전신 자가면역 질환의 일부일 수 있습니다.

- 눈/입/피부/심음/호흡음 등 체크